

居宅サービス計画書（第1表）

作成年月日	令和8年5月1日	計画作成者氏名	介護支援専門員 山田 太郎
利用者氏名	鈴木 茂 様	事業所名	ケアプランセンター〇〇
生年月日	昭和21年（82歳）	性別	男
住所	〇〇市〇〇町2-3-4		
要介護状態区分	要介護3	区分支給限度 基準額	27,048単位 [新規]

利用者及び家族の生活に対する意向
本人意向： 「脳梗塞で左半分が動かなくなり情けない。でも、妻の負担を減らすために、せめてトイレは手すりを使って自分で済ませられるようになりたい」 家族意向（妻・79歳）： 「夫を自宅で看たいが、夜間の排泄介助で寝不足が続き、私の腰痛も悪化してきた。共倒れにならないよう助けてほしい」

介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
なし

総合的な援助の方針
令和8年2月の脳梗塞発症による左片麻痺・体幹機能低下に対し、退院後の在宅生活移行に伴う排泄動作の自立と家族の介護負担軽減が急務。本人の「妻に迷惑をかけたくない」という想いと、妻の健康維持を両立させるため、①リハビリ専門職によるトイレ動作訓練と環境整備、②夜間リハビリパンツ導入等による夜間排泄の自立化、③通所リハ利用による妻の休息（レスパイト）確保、の3点を方針とし、主治医と密に連携しながら生活再構築を図る。 【緊急時連絡先】 妻：鈴木 〇〇（固定）／長女：▲▲（携帯 090-▲▲▲▲-▲▲▲▲）／主治医：鈴木リハ病院（電話 ▲▲-▲▲▲▲）

生活援助中心型の算定理由	該当なし
--------------	------

同意欄 上記計画について説明を受け、内容に同意し交付を受けました。 令和8年5月1日 利用者署名：鈴木 茂
--

居宅サービス計画書（第2表）

【生活全般の解決すべき課題（ニーズ）と援助目標・内容】

生活全般の解決すべき課題 (ニーズ)・〔課題分析〕	長期目標 (期間)	短期目標 (期間) / ※評価指標	サービス内容・頻度・事業所
1. トイレ排泄の部分自立困難 自宅環境不備と左片麻痺により、トイレ排泄が安全にできない。 〔課題分析〕 自宅トイレの狭さと手すり不在、体幹ふらつきが要因。環境整備と訓練で部分自立可能。	トイレの手すりを使用し、日中は介助なしで安全に排泄ができる。 (R8.5.1 ～ R8.10.31)	手すりを活用した立ち上がり手順を習得し、日中のトイレ動作のふらつき・ヒヤリハットがゼロになる。 (R8.5.1 ～ R8.7.31) ※評価指標：排泄動作FIM点数（現在2点→目標4点）、ふらつき回数	【通書リハビリ】 理学療法士による移乗・ズボン着脱訓練 事業所：鈴木リハクリニック 頻度：週2回（月・木）
2. 妻の介護負担増と共倒れリスク 夜間の排泄介助による妻の睡眠不足と腰痛の悪化。 〔課題分析〕 夜間の高頻度覚醒と介助量が原因。福祉用具と訪問介護の組み合わせで負担を分散。	妻が夜間6時間以上の連続睡眠を確保でき、腰痛が軽減される。 (R8.5.1 ～ R8.10.31)	夜間が高吸収パンツとポータブルトイレを活用し、妻を起こす回数が「毎晩3回」から「週2回以内」に減少する。 (R8.5.1 ～ R8.7.31) ※評価指標：妻の睡眠時間、夜間呼び出し回数の記録	【訪問介護（身体介護）】 就寝前の排泄介助・移乗見守り 事業所：ヘルパーケア〇〇 頻度：週3回（火・水・金）
インフォーマルサポート	近隣に住む長女が毎週日曜日に訪問。妻の腰痛が強い日は夕食を持参し、鈴木氏の入浴（見守り）を手伝う。		

居宅サービス計画書（第3表）

【週間サービス計画表】

時間帯	月	火	水	木	金	土	日
9:00 ～ 15:00	通所リハ 鈴木リハ (移乗・着脱訓練)			通所リハ 鈴木リハ (移乗・着脱訓練)		自主リハ (立ち上がり練習)	【インフォーマル】 長女訪問 (入浴サポート・家事援助)
20:30 - 21:00		訪問介護 就寝前排泄・ 移常	訪問介護 就寝前排泄・ 移常		訪問介護 就寝前排泄・ 移常		
その他							

モニタリング	毎月1回、訪問リハ専門職からのフィードバック（動作分析FIM）と、妻の睡眠・腰痛状態を評価指標に基づいてヒアリング。3か月後に検証を行う。
--------	---